



FORUM DE CANCEROLOGIE DE ROCHE

Cancer du sein précoce HER2+

OUVRIR DES PERSPECTIVES

DANS LA PERSONNALISATION DU TRAITEMENT
pour les patientes présentant une maladie résiduelle
invasive après un traitement néoadjuvant^{1,2}

ÉTUDE KATHERINE



www.forumcancerologie-roche.com



Roche

CANCER DU SEIN PRÉCOCE HER2+¹

TRAITEMENT NEOADJUVANT²

Chimiothérapie à base de taxane + traitement anti-HER2

CHIRURGIE

Réponse
pathologique
complète

Maladie
invasive
résiduelle

Traitement
anti-HER2²

Etude

KATHERINE

**Trastuzumab
emtansine**

pendant 14 cycles¹

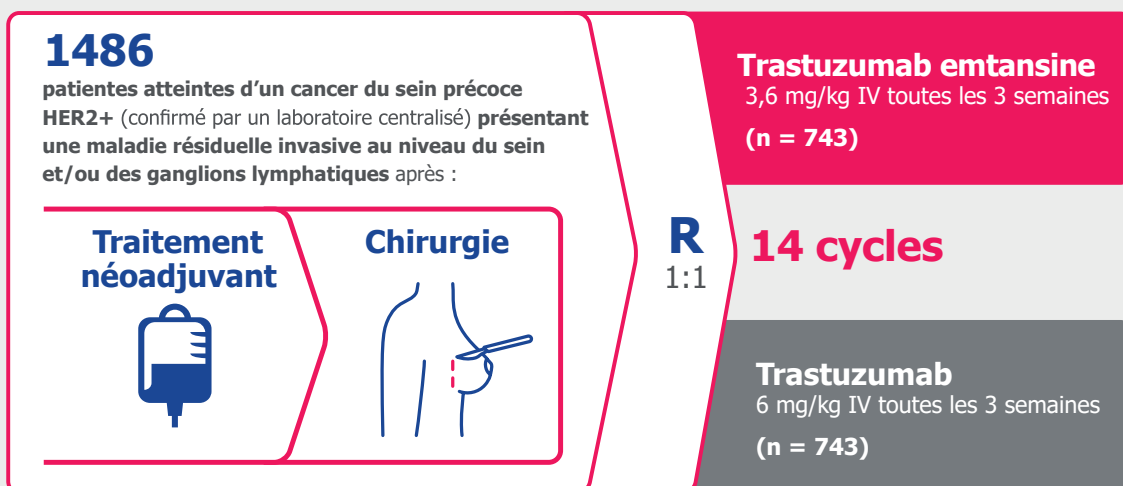
Trastuzumab emtansine®, en monothérapie, est indiqué dans le traitement adjuvant de patientes adultes atteintes d'un cancer du sein précoce HER2 positif qui présentent une maladie résiduelle invasive, au niveau du sein et/ou des ganglions lymphatiques, après un traitement néoadjuvant à base de taxane et d'un traitement anti-HER2¹

ÉTUDE KATHERINE

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE³

Objectif :

- Etude de phase III internationale, multicentrique (268 centres dans 28 pays), randomisée, en ouvert
- **Objectif :** évaluer l'efficacité et la tolérance de **Trastuzumab emtansine** vs trastuzumab en tant que traitement adjuvant chez des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HER2+ et présentant une maladie résiduelle invasive au niveau du sein et/ou des ganglions lymphatiques axillaires, après un traitement systémique préopératoire ayant comporté une chimiothérapie à base de taxane et trastuzumab
- **Schéma de l'étude³**



Cancer du sein précoce HER2+

CRITÈRES D'ÉVALUATION³

Analyse en ITT (intention de traiter)

CRITÈRE PRIMAIRE

- **Survie sans maladie invasive**
Définie comme le temps entre la date de randomisation et la date de première apparition d'une récurrence ipsilatérale d'une tumeur du sein invasive, d'une récurrence locale ou régionale ipsilatérale d'un cancer du sein invasif, d'une récurrence à distance, d'un cancer du sein invasif contralatéral ou d'un décès, quelle qu'en soit la cause.

CRITÈRES SECONDAIRES

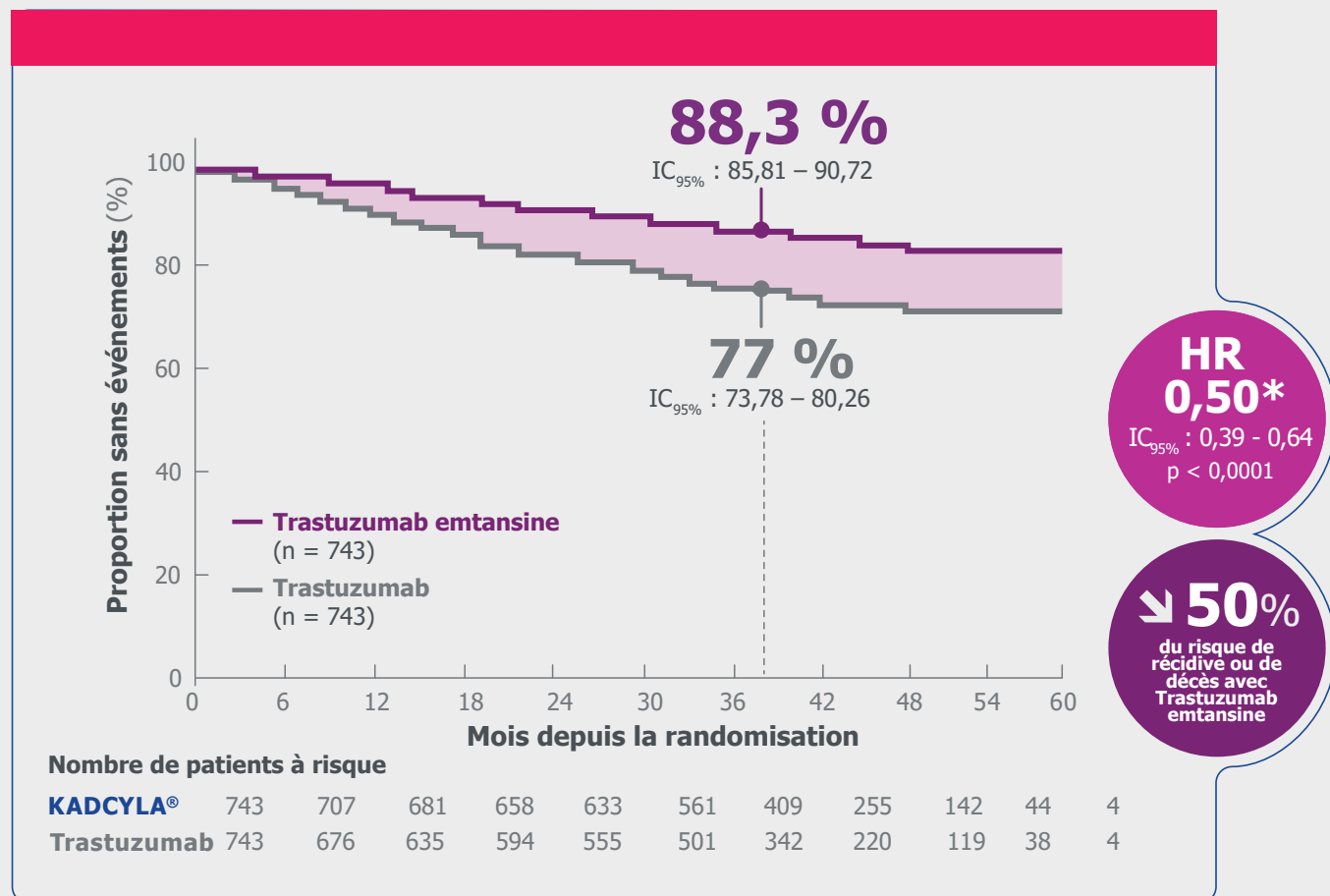
- **Survie sans maladie invasive incluant un 2^e cancer primitif autre qu'un cancer du sein**
- **Survie sans maladie**
- **Survie globale (OS)**
- **Tolérance générale**

ÉTUDE KATHERINE

RÉSULTATS D'EFFICACITÉ³

SURVIE SANS MALADIE INVASIVE À 3 ANS

Critère primaire



Amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie sans maladie invasive à 3 ans avec un bénéfice absolu de + 11,3% avec Trastuzumab emtansine vs trastuzumab

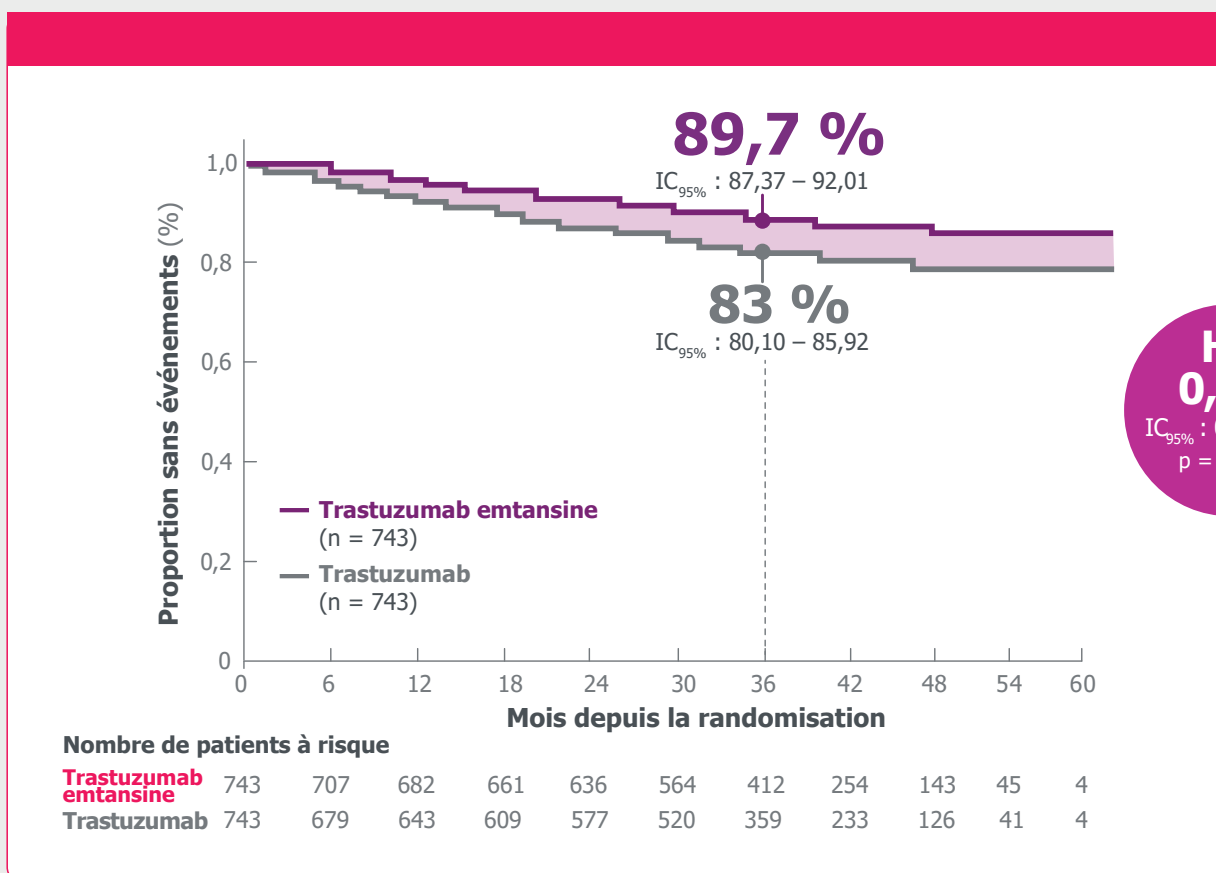
Nombre de patients avec événements :

- **Trastuzumab : 165** (22,2 %)
- **Trastuzumab emtansine : 91** (12,2 %)

Cancer du sein précoce HER2+

POURCENTAGE DE PATIENTS SANS RÉCIDIVE À DISTANCE À 3 ANS³

Critère secondaire



Trastuzumab emtansine réduit de manière statistiquement significative le risque de récidive à distance vs trastuzumab

Nombre de patients avec événements :

- Trastuzumab : 121 (16,3 %)
- Trastuzumab emtansine : 78 (10,5 %)

ÉTUDE KATHERINE

TOLÉRANCE³

INCIDENCE DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (EI)

	trastuzumab (n = 720)	Trastuzumab emtansine (n = 740)
EI de tous grades	93,3 %	98,8 %
EI de grade ≥ 3	15,4 %	25,7 %
EI avec une issue fatale	0 %	0,1 %
EI graves	8,1 %	12,7 %
EI conduisant à l'arrêt de traitement	2,1 %	18 %
Décès	7,8 %	5,7 %

Pour toute déclaration d'évènements indésirables merci d'envoyer un mail à Roche Côte d'Ivoire Sarl au global.irtsahubtcs@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55

Pour toute demande d'information médicale merci d'envoyer un mail à westafrica.medinfo@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55.

ROCHE Côte d'Ivoire SARL
Ivoire Trade Center, Cocody les ambassades Angle de la rue Hassan 2 et de la rue Booker Washington, Bâtiment D 1er étage
18 BP 2377 Abidjan 18, Côte d'Ivoire
Tél : +225 27 22 48 23 55